

Распространенность основных форм злокачественных опухолей у детей в Казахстане

Жумашев У.К.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

УДК: 614,2:616 – 006.4:616 – 053.2(574)

В отечественной литературе мало работ, посвященных эпидемиологии злокачественных новообразований у детей. Отдельными работами являются исследования, проведенные в России Дурновым Л.А., Заридзе Д.Г., Ли Н.А., которые показали, что уточненная заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей примерно в 30%, а в некоторых регионах на 50% выше, чем та, которая устанавливается на основании официальных отчетов [Аксель Е.М., Двойрин В.В. 1993; Дурнов Л.А. 1995; Заридзе Д.Г. и соавт. 1993].

Углубленное эпидемиологическое изучение заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей детского населения Казахстана является актуальной задачей современной онкологии. Поскольку, целенаправленных эпидемиологических исследований показателей заболеваемости и смертности детского населения от злокачественных опухолей с учетом определенных компонентов онкологической помощи влияющих на их уровень не проводились. Поэтому, одной из центральных задач данного исследования является ранжирования злокачественных опухолей по степени значимости отдельных компонентов состояния онкологической службы детского населения. Подобные исследования в Казахстане, проводится впервые, и получаемые результаты представляют определенный практический и теоретический интерес. Важными моментами при этом являются: единая методика расчета показателей и критерий (стандарты) для их оценки. Критерии оценки могут иметь различный уровень: региональный, казахстанский, европейский, мировой. В результате введения критериев оценки медико-статистических показателей при изучении злокачественных новообразований в практику детских онкологических отделений и центров станет возможным получение сравнимой информации, получаемой внутри страны и за рубежом [Duncan M.H. et al 1986; Мерабишвили В.М., Старинцев В.В. 1995].

Материалы и методы исследования

При изучении статистики отдельных форм злокачественных опухолей детского населения в Казахстане использовано материалы 2951 больных за 1997-2006 гг. и из них лейкозы – 739, опухоли головного мозга – 563, лимфомы – 466 с использованием современных методов санитарной статистики [Двойрин В.В., Дурнов Л.А. 1995; Заридзе Д.Г. и соавт. 1993].

Результаты исследования и обсуждение

Злокачественные новообразования у детей и взрослых существенно отличаются по их частоте и виду. В структуре злокачественных новообразований всего населения на долю детей приходится в среднем 10,2%.

Лейкозы. За 1997-2006 гг. в республике зарегистрировано 739 больных детей лейкозами, что составляет

Анализировано 2951 больных детей зарегистрированных за 1997-2006 годы в Казахстане. Из них Лейкозы – у 739 (25% - первое место), опухоли головного мозга – у 563 (19,1% - второе место), Лимфомы – у 466 (15,8% - третье место), опухоли мягких тканей – у 291 (9,9% - четвертое место), опухоли костей – у 270 (9,2% - пятое место), и далее по рангу нефробластома – у 207 (7,0%), нейробластома – у 114 (4,0%), опухоли глаз – у 106 (3,6%), опухоли яичко – у 57 (1,9%), опухоли печени – у 48 (1,7%), опухоли яичников – у 47 (1,6%) и Лангергансо-клеточные гистиоцитозы – у 43 (1,5%) больных детей.

Выявлено неравномерное распределение больных злокачественных опухолей у детей в различных областях Республики, что обусловлено с неполноценностью учета больных детей. Следовательно необходимо, улучшение онкологической помощи больным детского населения путем повышения выявляемости и ранней диагностики, а также налаживания полноценности учета злокачественных опухолей детского населения.

Қазақстандағы балаларда кездесетін қатерлі ісіктердің кездесу жиілігі

Жұмашев У.Қ.

С.Ж. Аспандияров атындағы Қақтың ұлттық медицина университеті, Алматы қ.

Қазақстанда 1997-2006 жылдар арасында қатерлі ісікпен ауырған 2951 науқасты сараптау кезінде, олардың: 739 – Лейкоз (25% - бірінші орында), 563 – мидың ісіктері (19,1% - екінші), 466 – қатерлі лимфомалар (15,8% - үшінші), 291 – жұмсақ тіннің ісіктері (9,9% - төртінші), 270 – сүйектің ісіктері (9,2% - бесінші орында), және ары қарай 207 – бүйректің ісіктері (7,0%), 114 – нейробластома (4,0%), 106 – көздің ісіктері (3,6%), 57 – ұлдардың аталық безінің ісіктері (1,9%), 48 – бауырдың ісіктері (1,7%), 47 – қыз балдардың аналық безінің ісіктері (1,6%) және 43 – гистиоцитоз ісіктері (1,5%) анықталған. Республикадағы науқастардың әртүрлі көрсеткіші олардың толық есепке алынбай, ісіктің әрқелкі анықталуын көрсетеді. Сондықтан республикадағы балалар онкологиялық жұмысын жандандырып, оларда кездесетін қатерлі ісіктерді дер кезінде анықтауды әрі жүйелі есепке алуды жақсарту керек.

Prevalence of the basic forms of malignant tumours at children in Kazakhstan

Zhumashev U.K.

Kazakh national medical university after S.D. Asfendijarova, of Almaty

Analyse 2951 sick children registred material for 1997-

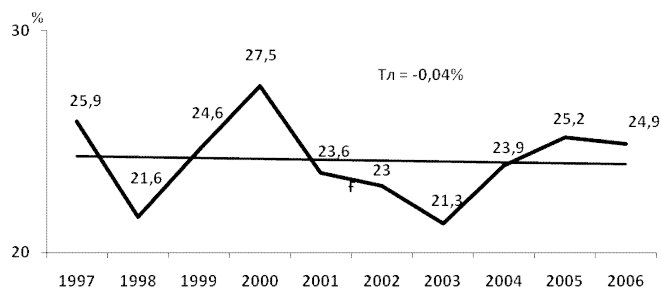


Рисунок 1- Динамика удельного веса больных лейкозом детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

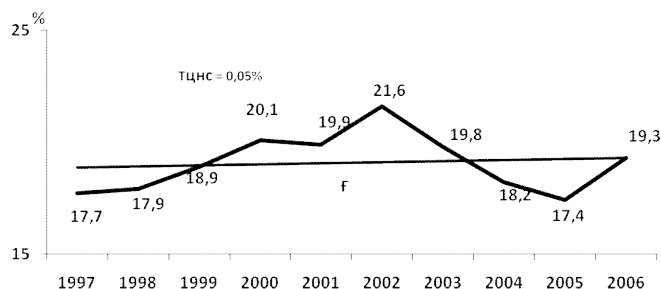


Рисунок 2- Динамика удельного веса больных опухолями ЦНС детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

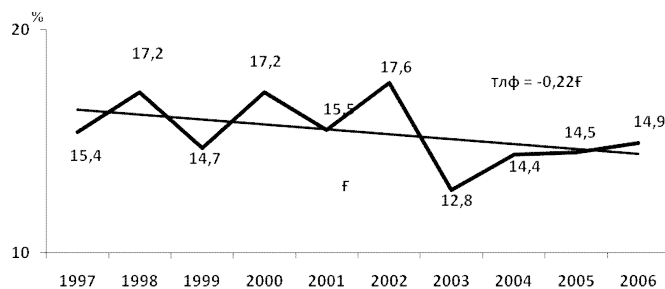


Рисунок 3- Динамика удельного веса больных лимфомами детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

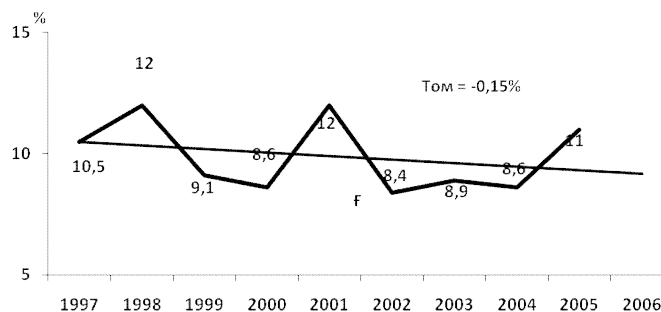


Рисунок 4- Динамика удельного веса больных опухолями мягкой ткани детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

25,0±0,8% и в структуре злокачественных опухолей детского населения занимает первое место. Распределение удельного веса лейкозов в динамике остается относительно стабильной (рисунок 1) с небольшой тенденцией к снижению ($Tл = -0,04\%$). Подобное снижение удельного веса лиц заболевших лейкозами обусловлено в основном недоучетом этих больных в различные годы в республике. Так удельный вес детей лейкозами в 1998 (21,6±2,4%) и 2001-2004 годах (23,6±2,4%, 23,0±2,4%, и 21,3±2,4%, соответственно) были ниже, чем среднереспубликанских данных.

Опухоли ЦНС. Данная форма опухоли в республике зарегистрировано 563 и составил в среднем 19,1±0,7% в структуре злокачественных опухолей детского населения, а занимает второе место и имеет тенденции к росту ($Tцнс = 0,05\%$) в результате улучшения диагностики и учета их в 2000-03 годах в республике (рисунок 2).

Лимфомы. За изучаемый период в республике зарегистрировано 466 больных детей со злокачественными

2006 in Kazakhstan. From them leukaemia - at 739, central nervous system - at 563, Lymphoid neoplasms- at 466, sarcoma of soft fabrics - at 291, tumours of bones - at 270, Wilms' tumor - at 207, neuroblastoma - at 114, tumours of eyes - at 106, Langerhans cell histiocytosis - at 43, tumours of sexual glands at boys - at 57, hepar tumours - at 48 and tumours ovary - at 47 sick children. It is established, that in structure of malignant tumors at children the first place occupies leukaemia (25 %), the second place tumors central nervous system (19,1 %) the third Lymphoid neoplasms (15,8 %) and further on a rank soft fabrics (9,9 %), bones (9,2 %), a tumour of kidneys (Wilms' tumor 7,0 %), etc.

Non-uniform distribution of sick malignant tumors at children in various areas of Republic that is caused with inferiority of the account of sick children is revealed. Hence it is necessary, improvement of the oncological help by the patient of the children's population by increase of detectability and early diagnostics, and also adjustment of full value of the account of malignant tumors of the children's population.

лимфомами (с лимфомой Ходжкина и Неходжкинской лимфомой), что составил в среднем 15,8±0,7% в структуре злокачественных опухолей детского населения и занимает третье место, при этом имеет тенденции к снижению ($Tлф = -0,22\%$) в результате недоучета их в 1999 и 2004-05 годах на территориях республики (рисунок 3).

Опухоли мягкой ткани у детей в республике за 1997-2006 гг. зарегистрировано всего 291 больных злокачественными опухолями мягкой ткани, а в структуре злокачественных опухолей детского населения в среднем составил 9,9±0,4% и занимает четвертое место. При этом доля больных с данной формой опухоли у детей имеет тенденции к снижению ($Том = -0,15\%$) в результате недоучета их, в 1999-2000 и 2002-2004 годах в целом по республике (рисунок 4).

Опухоли кости. Данный вид опухоли у детей в республике за 1997-2006 гг. зарегистрировано всего 270 больных злокачественными опухолями кости, а в структуре злокачественных опухолей детского населения в среднем составил 9,2±0,4% и занимает пятое место. В динамике доля больных с данной формой опухоли у детей имеет тенденции к росту ($Ток = 0,14\%$) (рисунок 5).

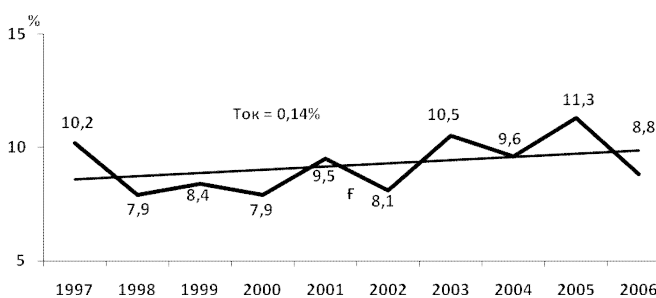


Рисунок 5- Динамика удельного веса больных опухолями кости детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

Обобщенные показатели злокачественных опухолей детского населения Казахстана по нозологическим единицам представлена на рисунке – 6, где установлены определенные закономерности характерные для нашей республики.

Среди злокачественных опухолей различных органов и тканей наиболее часто диагностируется лейкозы (25,0%), опухоли центральной нервной системы (19,1%) и лимфомы (15,8%) которые составляют 59,9% всех онкологических больных детей. Из остальных форм злокачественных опухолей относительно чаще выявляются у детей опухоли мягкой ткани (9,9%) и костей (9,2%), опухоли почек (нефробластома 7,0%). Сравнительно реже нейробластома

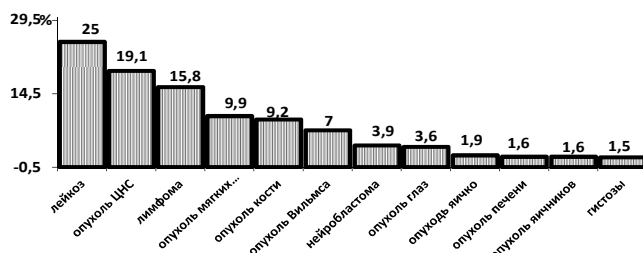


Рисунок 6- Динамика удельного веса больных злокачественными опухолями детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

(3,9%), опухоли глаз (3,6%), а крайне редко встречаются опухоли яичко, печени, яичников и др. Кроме того такие как «типичные» опухоли взрослых - рак желудка, кишечника, молочной железы и др. чрезвычайно редко.

Таким образом, при анализе экстенсивных показателей злокачественных опухолей у детей в Казахстане выявлено: в структуре злокачественных опухолей у детей первые пять место занимает Лейкозы - $25,0 \pm 0,8\%$, второе место ЦНС - $19,1 \pm 0,7\%$, лимфомы третье место $15,8 \pm 0,7\%$, опухоли мягких тканей четвертое - $9,9 \pm 0,4\%$, и опухоли костей $9,2 \pm 0,4\%$ пятое место. Кроме того выявлено неравномерная доля больных злокачественных опухолей у детей в различных областях оказались неодинаковой, что обусловлена с неполноценностью учета больных детей в отдельных регио-

нах Казахстана. Следовательно, необходимо улучшение онкологической помощи больным детского населения путем повышения выявляемости и ранней диагностики, а также налаживания полноценности учета злокачественных опухолей детского населения нашей Республики.

Литература

1. Аксель Е.М., Двойрин В.В. Заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения России. // Матер. Симпозиума по детской онкологии Москва, 20-22 окт. 1993;
2. Двойрин В.В., Дурнов Л.А. Сравнительная заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения стран мира. // М: ОНЦ РАМН. - 1995. С. 70-71.
3. Заридзе Д.Г., Ли Н.А., Мень Т.Х. Заболеваемость детей злокачественными опухолями в четырех областях Казахстана, прилегающих к ядерному полигону // Мед. Радиология - 1993. №11
4. Duncan M.H., Wiggins C.H., Samet J.M., Key C.R. Childhood cancer epidemiology in Mexican American Indians, Hispanic Whites and Nonhispanic Whites, 1970-1982. // J.N.C.I. - 1986- V.76.-R6;
5. Мерабишвили В.М., Старинский В.В. Организация раковых регистров в России // Проблемы современной онкологии (тезисы докладов IV Всероссийского съезда онкологов). Ростов н/Д, 1995. С. 70-71.